

КОНІКОТОМІЯ

Сценарій. Бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлена пацієнтка 40 років з діагнозом: «Анафілактичний шок. набряк язика, гортані».

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Дзеркало Кілліана або зажим гнутий Більрота	1 шт.
2	Хірургічний пінцет	1 шт.
3	Хірургічний лоток	2 шт
4	Голкотримач	1 шт
5	Хірургічну голку	1 шт
6	Пульсоксиметр	1 шт
7	Скальпель	1 ш



№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Перекопатися у відсутності небезпеки для себе та постраждалого, коректне розташування пацієнт-лікар, позначити свою роль	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій (можливо/неможливо отримати)	Сказати
3	Обробити руки хірургічним способом (лікар в рукавичках), надіти стерильний одяг, окуляри	Виконати
4	Пальпація і стабілізація гортані: - встати біля плеча пацієнта - розігнути голову пацієнта - невідомою рукою пропальпувати гортань - 1 та 3 пальцями руки зафіксувати персневидний хрящ, вказівним пальцем позначив місце розрізу	Виконати
5	Розрізати мембрану (утримуючи скальпель в правій руці під кутом 60 градусів до шкіри, зробити горизонтальний розріз мембрани 1,5 см, при цьому гостра частина леза звернена до	Виконати

	оператора та глибина розрізу обмежена довжиною леза)	
6	Утримати просвіт трахеї та зробити каудальну тракцію гортані: - використовуючи скальпель як провідник, однією рукою завести просвіт трахеї трахеальний гачок - ротувати гачок донизу, підчепив гачком перстнеподібний хрящ і здійснив тракцію його каудально для створення максимального просвіту трахеї	Виконати
7	Утримати просвіт трахеї та зробити каудальну тракцію гортані: - ротувати гачок донизу, підчепив гачком перстнеподібний хрящ і здійснив тракцію його каудально для створення максимального просвіту трахеї	Виконати
8	Інтубація (завести інтубаційну трубку в куадальному напрямку, роздути манжету, перевірити симетричність вентиляції)	Виконати/ Сказати
9	Фіксувати ендотрахеальну трубку	Виконати

Діагностика

3.1. Оцінка гемостазу, аеростазу рани

Сказати: «Оглядаю ділянку розтину: кровотеча незначна, зупинена — гемостаз досягнуто. Повітря з рани або підшкірної емфіземи не виявлено — ознак порушення

аеростазу немає. Конікотомічна трубка на місці, фіксована надійно.»

3.2. Оцінка ефективності вентиляції легень

Сказати: «Після конікотомії покращилась прохідність дихальних шляхів:

- зменшилась вираженість задухи,
- дихання стало глибшим,
- амфоричне дихання вислуховується з обох боків,
- зменшився ціаноз.

ЧДР знизилась, сатурація (за наявності моніторингу) покращилась. Це свідчить про ефективну вентиляцію через конікотомічну трубку.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Необхідність додаткових методів дослідження (бронхоскопія, КТ)

Сказати: «Після стабілізації стану показана бронхоскопія для оцінки ступеня набряку

гортані та контролю положення трубки. Також можна провести КТ органів грудної клітки при підозрі на ускладнення з боку трахеї або легень.»

4.2. Призначення медикаментозної терапії (антибактеріальна/гемостатична)

Сказати:

«Продовжую введення:

- глюкокортикостероїдів (преднізолон/дексаметазон);
- антигістамінних препаратів (супрастин);
- адреналіну (за протоколом анафілактичного шоку);
- антибіотиків для профілактики інфекцій після інвазивного втручання;
- інфузійна терапія для стабілізації АТ.

Також проводжу моніторинг АТ, ЧСС, дихання, сатурації. Пацієнтка передається в реанімаційне відділення для інтенсивної терапії.»